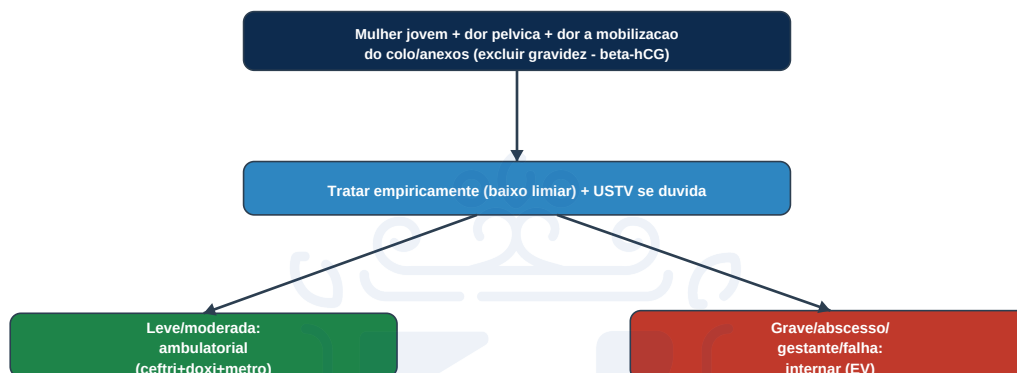


DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA (DIP)

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

DIP — TRATAR CEDO, COBRIR GONO + CLAMÍDIA



DEFINIÇÃO E AGENTES

O QUE É

- Processo inflamatório da pelve por ascensão de micro-organismos do colo/vagina para endométrio, tubas, peritônio e anexos
- Geralmente POLIMICROBIANA
- Agentes primários: *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*
- Outros: anaeróbios, gram-negativos, *Mycoplasma*, *Gardnerella*, etc.
- Fatores de risco: jovem, múltiplos parceiros, sexo desprotegido, IST prévia/actual, DIU recente

QUANDO SUSPEITAR — CLÍNICA E EXAME

BAIXO LIMIAR DIAGNÓSTICO

- Dor pélvica bilateral (de leve desconforto a intensa), pior durante/após a menstruação
- Disúria, dispareunia, febre, alteração do ciclo; pode ser oligo/assintomática
- Exame especular: secreção purulenta/muco turvo no colo, friabilidade do colo
- Toque: DOR À MOBILIZAÇÃO DO COLO, dor anexial, massas/endurecimento
- Tratar empiricamente diante de dor pélvica + dor à mobilização do colo/anexos (após excluir gravidez)

EXAMES E CRITÉRIOS DE IMAGEM

INVESTIGAÇÃO

- Hemograma, urina 1 + urocultura, VHS/PCR, bacterioscopia (vaginose), BETA-HCG (excluir gravidez/ectópica)
- USTV: espessamento de parede tubária > 5 mm, líquido tubário, sinal da 'roda dentada', complexo/abscesso tubo-ovariano
- Critérios de imagem específicos (sem necessidade de mais nada): abscesso tubo-ovariano ao USG/RM
- Outros critérios definitivos: biópsia endometrial com endometrite; laparoscopia com sinais de salpingite
- Rastrear clamídia, gonococo e HIV em toda DIP

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

EXCLUIR

- Gravidez ectópica (sempre dosar beta-hCG)
- Apendicite aguda
- Cisto ovariano roto ou torcido
- ITU / litíase urinária
- Endometriose

TRATAMENTO — AMBULATORIAL x HOSPITALAR

Cenário	Esquema
Ambulatorial (leve/moderada)	Ceftriaxona 500mg IM dose única + Doxíciclina 100mg VO 12/12h por 14 dias + Metronidazol 500mg VO 12/12h por 14 dias
Hospitalar / EV (grave, abscesso, gestante, falha)	Ceftriaxona EV + Doxíciclina + Metronidazol OU Clindamicina + Gentamicina EV
Abscesso tubo-ovariano	Internação + ATB EV (associar metronidazol/clindamicina); drenagem se grande/refratário
Parceiro(s)	TRATAR sempre: Ceftriaxona 1g (cobrir gono/clamídia), independentemente de sintomas

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO E SEGUIMENTO

INTERNAR / REAVALIAR

- Internar: abscesso tubo-ovariano, gestação, sepse/quadro grave, intolerância/falha da via oral, dúvida diagnóstica (ex.: abdome agudo cirúrgico)
- Abscesso tubo-ovariano: regime hospitalar com ATB EV; drenagem (inclusive via vaginal se fundo de saco) se necessário
- Seguimento ambulatorial: REAVALIAR em 72h — hospitalizar se não houver melhora
- Sem melhora: avaliar cirurgia (abscessos em outros locais; Fitz-Hugh-Curtis = peri-hepatite) ou resistência ao esquema
- Rastrear HIV e demais ISTs; orientar uso de preservativo

MODELO DE ENCAMINHAMENTO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Mulher ____ anos com DIP (dor pélvica + dor à mobilização do colo/anexos); beta-hCG negativo.
- USTV: ____ (abscesso tubo-ovariano?); PCR/VHS ____; gravidade ____.
- Conduta: ATB ambulatorial (ceftri+doxi+metro) OU internação/EV; parceiro tratado.
- Solicito internação/avaliação ginecológica se abscesso/gravidez/falha terapêutica.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Mulher de 24 anos, dor pélvica, dor à mobilização do colo e secreção purulenta, beta-hCG negativo, sem abscesso. Conduta?

- A) Aguardar cultura antes de qualquer tratamento
- B) Tratar empiricamente (ceftriaxona + doxiciclina + metronidazol) e tratar o parceiro
- C) Apenas analgésico e alta
- D) Histerectomia
- E) Antiviral

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Quais são os agentes etiológicos primários da DIP?

- A) E. coli e Klebsiella
- B) Neisseria gonorrhoeae e Chlamydia trachomatis
- C) Candida e Gardnerella
- D) Staphylococcus aureus
- E) Trichomonas vaginalis

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual exame é obrigatório antes de tratar uma suspeita de DIP?

- A) Tomografia de abdome
- B) Beta-hCG (excluir gravidez/ectópica)
- C) Ressonância de pelve
- D) Colonoscopia
- E) Eletrocardiograma

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual achado ao USG transvaginal indica DIP sem necessidade de critérios adicionais?

- A) Útero de tamanho normal
- B) Abscesso tubo-ovariano / complexo tubo-ovariano
- C) Endométrio fino
- D) Cisto folicular simples
- E) Ausência de líquido livre

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre o manejo do parceiro na DIP, é correto:

- A) Não é necessário tratar o parceiro
- B) O parceiro deve ser tratado (ex.: ceftriaxona) mesmo que assintomático
- C) Tratar apenas se sintomático
- D) Tratar somente após cultura positiva da paciente
- E) Tratar apenas com antifúngico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A DIP tem baixo limiar de tratamento: diante de dor pélvica + dor à mobilização do colo/anexos (beta-hCG negativo), trata-se empiricamente com ceftriaxona + doxiciclina + metronidazol, sem aguardar culturas, e trata-se o parceiro.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Os agentes primários são *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis*, embora a DIP seja frequentemente polimicrobiana (incluindo anaeróbios e gram-negativos).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O beta-hCG é obrigatório para excluir gravidez (especialmente ectópica) antes de tratar/conduzir uma suspeita de DIP, pois muda completamente o manejo.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A presença de abscesso/complexo tubo-ovariano ao USG transvaginal (ou RM) é critério específico de DIP, dispensando achados adicionais e indicando internação com ATB EV.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O(s) parceiro(s) deve(m) ser tratado(s) sempre (ex.: ceftriaxona para gono/clamídia), mesmo assintomáticos, para evitar reinfecção; também se rastreia HIV e outras ISTs.

SM24
Suporte ao Plantão Médico